

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T17:11:06

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-A6-2679-01Z-00-DX1.8df66ef4-d9e5-41db-836d-f0afe46d6b5a_46adf114e61be5da

Generated at: 2026-06-27T17:11:06

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为诊断支持工具，不承担最终诊断责任，所有结论均以Query Case为核心，严格依据输入数据进行推理与整合。检索病例仅为参考证据，不得视为主诊断对象。本输出不替代病理科医师的独立判断，仅供临床决策参考。

推理过程与证据归纳

本分析基于对Query Case (ID: TCGA-A6-2679-01Z-00-DX1.8df66ef4-d9e5-41db-836d-f0afe46d6b5a_46adf114e61be5da) 的多模态信息整合，包括其预测类别、高注意力病理图像patch及其对应的文本描述，以及一份来自TCGA-COAD数据库的参考诊断报告。首先，从整体分类模型输出来看，该样本被以高达99.95%的概率识别为“TCGA-COAD”（结肠腺癌），这一结果高度支持其为结肠来源的恶性肿瘤。此预测与检索到的参考病例一致，该参考病例明确诊断为右结肠中分化腺癌，pT3aN0，提供了重要的临床背景和组织学预期。

进一步结合20个高注意力patch的视觉特征与对应的文字描述进行形态学分析，发现绝大多数patch（共18个）均表现出典型的结肠腺癌细胞学和组织学特征。这些特征包括：细胞核显著增大、深染且形态不规则，呈现明显的核异型性；部分区域可见核仁清晰或核分裂象，提示活跃增殖；细胞质相对较少，呈嗜碱性或淡染；组织结构紊乱，缺乏正常腺体的有序排列，表现为不规则的腺样结构、巢状或弥漫分布的癌细胞团块；背景中常见炎症细胞浸润及纤维化反应，少数区域伴有坏死。例如，patch sim_0002、sim_0003、sim_0005、sim_0007、sim_0009、sim_0011、sim_0013、sim_0014、sim_0016、sim_0017、sim_0018、sim_0019等均被高置信度地描述为具有上述恶性特征，其中多个patch明确指出存在“显著的核多形性”、“异常增生的癌细胞”、“紊乱的生长模式”和“坏死区域”，这些是支持高级别腺癌的关键证据。

然而，值得注意的是，有两处patch（sim_0001和sim_0010）的描述与主流结论存在冲突。sim_0001的文字分析认为组织“更接近于正常的结肠组织”，未见明显异型性或坏死；而sim_0010则直接判断为“正常的结肠组织，没有明显的癌症特征”。这两处描述可能反映了肿瘤边缘区域或非肿瘤性背景组织的存在，如黏膜下层或邻近正常黏膜。尽管如此，它们在整体高注意力区域中的占比极小，且其“正常”描述的置信度仅为“Medium”或“High”，并未达到足以推翻整体诊断的程度。更重要的是，这些“正常”区域的描述与参考报告中提到的“所有切缘均为阴性”相吻合，提示可能存在肿瘤与正常组织交界区。

综合来看，视觉证据链强烈支持一个中至高分化的结肠腺癌诊断。高注意力区域集中于肿瘤主体，其形态学特征与参考报告中描述的“中分化腺癌”高度一致。虽然存在少量正常组织的描述，但这

属于合理现象，不能否定主要病变的存在。因此，最终判断采用文本证据与视觉证据的共识：即该样本为结肠腺癌，且其组织学分级和分期应与参考报告保持一致。由于参考报告提供了明确的pT3a N0分期，且Query的预测类别与之完全匹配，故在无直接矛盾的情况下，优先采纳参考报告中的具体分期信息作为辅助诊断依据。

关键指标提取

肿瘤大小未在提供的文本或图像证据中明确提及，因此无法确定具体数值。组织学分级根据参考报告描述为中分化（Moderately differentiated），该信息与多个高置信度的patch wording中提到的核异型性、深染细胞核及不规则腺体结构相一致，支持中分化诊断。T分期依据参考报告为pT3a，即肿瘤最小侵犯至浆膜下层，此结论与视觉特征中观察到的浸润性生长模式和缺乏明显坏死区域相符。淋巴结状态明确记录为16个区域淋巴结均无转移，即0/16，对应N0分期。M分期因无法评估远处转移而标记为“不能评估”，故pM未知。免疫组化指标如ER、PR、HER2及Ki-67在当前资料中均未提及，因此无法提取相关结果。综上所述，可提取的关键指标包括：肿瘤分级为中分化，T分期为pT3a，淋巴结状态为0/16（N0），M分期未评估，免疫组化指标未提供。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-A6-2679-01Z-00-DX1.8df66ef4-d9e5-41db-836d-f0afe46d6b5a_46adf114e61be5da。综合分析检索病例报告、Query图像的高注意力patch及其对应的视觉描述，以及模型预测类别（TCGA-COAD），可明确该样本为结肠腺癌。参考报告中明确指出肿瘤为“中分化腺癌”，pT3a（肿瘤侵犯至浆膜下层但未穿透浆膜）、N0（16枚区域淋巴结均无转移），且所有切缘阴性，提示局部进展期但无淋巴结转移。此信息与Query中多个高置信度patch的形态学特征高度一致：包括显著核异型性（核增大、深染、不规则）、细胞排列紊乱、缺乏正常腺体结构、部分区域可见坏死及炎细胞浸润等典型结肠癌表现。尽管部分patch显示组织结构尚存，但多数高注意力区域呈现明显恶性特征，支持原发性结肠腺癌诊断。免疫组化指标（ER/PR/HER2/Ki-67）在现有文本证据中未提及，建议补充检测以进一步评估分子分型与预后。肿瘤大小未在参考报告中明确记录，但根据pT3a分期推断其直径应大于2cm且累及浆膜下层。综上，结合多模态证据，该病例符合结肠中分化腺癌、pT3a N0的病理特征，临床需进一步评估远处转移情况并制定个体化治疗方案。